DOI:10.13463/j.cnki.cczyy.2020.02.038

头皮针联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语

张若萌[1]，孙善斌[2*]
（1. 安徽中医药大学研究生院，合肥 230038；2. 安徽中医药大学第二附属医院，合肥 230000）

摘要：目的 探讨头皮针联合言语康复在干预脑卒中后运动性失语方面的疗效，对头皮针结合言语康复和单纯言语康复的疗效进行比较。**方法** 选取脑卒中后运动性失语患者 76 例，按随机对照原则分成治疗组和对照组，每组 38 例。2 组均予以言语康复训练，治疗组在此前的基础上联合头皮针治疗。观察 2 组在中国康复研究中心汉语标准失语检查表（CRRCAE）得分，对患者言语功能进行评价。**结果** 治疗组治疗后 CRRCAE 中的各项言语功能评分均明显高于治疗组治疗前及对照组（$P < 0.05$）。治疗组临床疗效总有效率为 94.7%，优于对照组的 89.4%（$P < 0.05$）。**结论** 头皮针联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语效果更为明显。

关键词：脑卒中；运动性失语；头皮针；言语康复
中图分类号：R743　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**2095-6258(2020)02-0339-04

Treatment of motor aphasia after stroke with scalp acupuncture and speech rehabilitation

ZHANG Ruomeng[1], SUN Shanbin[2*]
(*1. Graduate School, Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei 230038, China; 2. The Second Affiliated Hospital of Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei 230000, China*)

Abstract: Objective To explore the efficacy of scalp acupuncture combined with speech rehabilitation in the intervention of motor aphasia after stroke, and to compare the efficacy of scalp acupuncture combined with speech rehabilitation and speech rehabilitation alone. **Methods** A total of 76 cases with motor aphasia after stroke were divided into treatment group and control group with 38 cases in each group. Both groups were intervened with speech rehabilitation training, and on the basis of that, the treatment group was treated with scalp acupuncture. The scores of Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination (CRRCAE) were observed to evaluate the patients' speech function in both groups. **Results** The speech function scores of the treatment group were significantly higher than those of the treatment group and the control group after treatment, with statistically significant differences (P<0.05). The total effective rate was 94.7% in the treatment group and 89.4% in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). **Conclusion** Scalp acupuncture combined with speech rehabilitation is more effective in the treatment of motor aphasia after stroke.

Keywords: stroke; motor aphasia; scalp acupuncture; speech rehabilitation

脑卒中是神经系统常见的疾病，伴随人口老龄化的加剧，发病率也在逐年增多[1]，其高复发、高致残的特征给个人学习生活、家庭和睦、社会和谐带来严重影响。研究[2]报道显示，多达 38% 的脑卒中患者会并发失语症。其中运动性失语是被了解最多、临床常见的一类失语，此类患者口语表达

基金项目：安徽省卫生计生委中医药科研课题项目（2016zy82）；安徽高校自然科学研究项目（KJ2018A0293）
作者简介：张若萌（1994—），女，硕士研究生，主要从事针灸的临床应用及机理研究
***通信作者：**孙善斌，男，主任医师，硕士研究生导师，电话 -13956020907，电子信箱 -zjssb@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

欠流利[3]，对命名、复述、说、阅读理解及书写能力存在较大缺陷，亦对含有语法词、语义关联词及秩序词的句子领悟受阻。近年来，国内学术研究者依然致力于将头皮针与言语康复训练有机结合起来，取得了一系列疗效成果[4]。笔者通过头皮针联合言语康复及单纯言语训练对脑卒中后运动性失语患者治疗前后中国康复研究中心汉语标准失语检查表（Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination, CRRCAE）的得分情况，分析 2 组临床疗效。报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选择 2017 年 1 月－2018 年 1 月安徽中医药大学第二附属医院康复科收治的 76 例脑卒中后运动性失语患者，随机分为治疗组和对照组，各 38 例。治疗组，男 21 例，女 17 例，年龄 38 ～ 72 岁，平均年龄（57.32±7.43）岁，平均病程（21.47±6.93）d，脑梗死 26 例，脑出血 12 例；对照组，男 23 例，女 15 例，年龄 37 ～ 70 岁，平均年龄（59.16±7.97）岁，平均病程（22.63±8.25）d，脑梗死 23 例，脑出血 15 例。2 组性别、年龄、卒中类型以及病程等方面比较，差异无统计学意义（$P > 0.05$），具有可比性。

1.2　诊断标准

中医诊断标准：参照 1996 年中国中医药管理局脑病急症协会制订的《中风病诊断疗效评定标准》[5]。西医诊断标准：参照中国第四届脑血管疾病学术研究会议修订的《各类脑血管疾病诊断要点》[6]，且经头颅影像学确诊为脑梗死或脑出血，依据 CRRCAE 证实患者脑卒中后发生失语类型为运动性失语[7]。

1.3　纳入标准

1）符合以上诊断标准，病情稳定，无意识障碍，能积极配合针灸及言语功能评分和训练者；2）年龄 35 ～ 75 岁，首次发病，开始康复时间距离发病时间不超过 1 个月，病程 6 个月以内；3）母语为汉语者；4）小学及以上文化程度者；5）同意并自愿参与者。

1.4　排除标准

1）合并严重视听障碍、认知障碍、构音障碍及有精神类疾病者；2）因严重的心、肺、肝、肾等重要脏器病变不能参加本研究者；3）严重并发症如肺部感染、尿路感染、一侧或双侧下肢静脉栓塞者；4）癫痫症病史者。

1.5　治疗方法

2 组均予以营养脑细胞、改善脑代谢、调脂、稳定斑块等药物治疗。

1.5.1　对照组　根据患者言语功能测评结果，遵循个体差异，制定相关康复内容。康复训练要求：言语训练室须保持安静，患者面对镜子，模仿治疗师动作以达到视觉反馈效果。先从简洁容易的动作和语句练起，再做难度适中训练，具体内容如下：1）构音训练：指导患者训练舌头的灵巧度，即做向前伸、向后缩、旋转、抵上颌、卷、舔等动作，再训练鼓腮、噘嘴、吹口哨等唇部运动，同时配合用冰、毛刷快速刺激软腭。2）发音训练：治疗师先发一个简单的元音，让患者看着镜子学习，如果可行，再发容易观察的辅音，可借用压舌板辅助发音。嘱患者发以上元音及辅音的时候可相对长时间地保持嘴型，无法发音的患者可先练习无声发音。3）命名训练：治疗师将 1 ～ 5 个实物放置患者面前，逐一问“这是什么（物品）”，当患者回答错误时，用实物或图片的第一个字的发音或描述实物的用途进行提示。4）复述训练：先从简单的单音节词开始，让患者重复，当患者能正确发音后，适当增大难度，让其复述一句话，最后再通过念一段文字，鼓励患者尽可能的复述，如果 1 次无法全部复述，就进行 2 次或多次练习直至熟练。5）阅读能力训练：同患者配合做字字配对的练习。摆出 5 ～ 10 张识字卡片，取出其中一张，让患者找出与治疗师手上相同字的卡片，并提问“选择的对吗”，待患者熟练掌握字字匹配后，可训练患者阅读短文的能力，提供一些简单的备选供患者选择。6）韵律训练：如用感叹词、疑问词、命令词、等表达不同情感的词句。7）书写训练：先从写简单的读卡识字开始，先让患者读出带有“火”字的卡片，向患者解释词的含义，将词义与书面文字联系起来，并引申与之相关实物，接着将卡片上的字翻转背对患者，让其听写并默写出来。8）交流能力训练：选择适合患者的话题为切入点，慢慢引导患者，使其掌握话语主动权，和他们谈论身边的人或物，让患者阐述自己的意见和观点，交流时给予语言和行为上的鼓励，增强患者交谈中的自信心。

1.5.2　治疗组　治则：醒脑开窍，化瘀通络。取穴：言语一区：上点在前后正中线连线的中点向后平移 0.5 cm，下点在眉枕线与鬓角发际线的交点，连接上下两点，此线下 2/5 即为言语一区（头面部运动区）；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

言语三区：耳尖直上 1.5 cm 处，向后引一条 4 cm 长的水平线。操作方法：体位，能正常行走者，取坐位；若行走困难，取仰卧位。手法，施针处常规消毒，治疗者一只手持天协牌规格 0.30 mm×40 mm 的一次性无菌针灸针，另一只手固定刺激区，当毫针和头皮呈 20 度左右角时，利用手腕背屈再掌屈的针刺方式快速进针，手下感触到达帽状腱膜后再缓缓推进 1 ～ 1.2 寸，此时，拇、食两指快速交替向逆时针和顺时针方向捻转达 200 次左右，每次持续 2 min，出现酸麻重胀等针感视为得气，共重复 3 次，留针 30 min。由于头皮血管丰富，起针时用干棉签按压针眼。

1.5.3　疗程　每天上午头皮针治疗后开展言语训练，每天 1 次，每周治疗 6 次，嘱患者每周休息 1 d，头皮针和言语治疗每次各 30 min。6 d 为 1 个疗程，共 8 个疗程。

1.6　疗效观察

观察指标按照《中国康复研究中心汉语标准失语症检查表》对患者治疗前后的语言能力进行康复评定，记录复述、命名、说、出声读、阅读、书写等 6 项言语功能评分。

疗效评定标准将《失语严重程度分级标准》与治疗前、后上述 6 项言语功能的提高程度相结合，将疗效测评标准划分成治愈、显效、有效和无效 4 个等级。治愈：言语较流利，能听懂他人表述的含义，正常沟通无障碍；显效：需要治疗师及家人少量辅助，与他人对话欠流利但吐字清楚，理解能力稍有不足；有效：可以准确读出单字或短句，存在理解障碍，与他人沟通需要大量提示；无效：不能表达，无法交流。

1.7　统计学方法

本研究数据采用 SPSS 19.0 统计学软件进行统计学处理，计数资料用 χ^2 检验，计量资料用 t 检验。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　2 组治疗前后言语功能比较

见表 1。

表 1　2 组治疗前后言语功能比较（$\bar{x} \pm s$，$n = 38$）　分

组 别	时间	复述	命名	说	出声读	阅读	书写
治疗组	治疗前	25.68±10.04	16.72±4.22	23.81±6.48	25.38±5.97	28.27±5.28	10.45±3.38
	治疗后	37.92±13.58#△	35.61±9.08#△	37.32±8.95#△	38.09±7.26#△	36.33±6.81#△	27.52±8.74#△
对照组	治疗前	23.17±9.53	14.03±4.15	18.49±5.70	21.62±4.35	23.16±4.03	14.83±3.09
	治疗后	32.85±11.44#	29.69±8.71#	31.98±7.07#	33.43±6.52#	34.83±5.47#	23.71±6.62#

注：与治疗前比较，#$P < 0.05$；与对照组比较，△$P < 0.05$

2.2　2 组临床疗效结果比较

见表 2。

表 2　2 组临床疗效结果比较（$n = 38$）　例

组别	治愈	显效	有效	无效	总有效率 /%
治疗组	6	17	13	2	94.7#
对照组	3	10	21	4	89.4

注：与对照组比较，#$P < 0.05$

2.3　2 组不良反应发生情况比较

见表 3。

表 3　2 组不良反应发生情况比较（$n = 38$）　例

组别	针刺痛	出血	血肿	晕针	总发生率 /%
治疗组	3	8	0	0	28.9#
对照组	5	10	2	1	47.4

注：与对照组比较，#$P < 0.05$

3　讨论

运动性失语在祖国医学上被称为“喑痱”“风懿”“不语”等，《素问》中“内夺而厥，则为喑痱……”是最早与其有关的文献记载。头为“诸阳之会”，说明头面部气血运行与全身的经络密切相关，且手足阳明、太阳、少阳经均走行过头，且督脉入属于脑，因此头皮针治疗脑部疾病效果明显[8]，可使患者醒脑启语。又有循行经过咽喉或舌的心、肝、肾等经脉理论作支撑，可见五脏与形成语言的发声器官联系紧密，故而头与五脏的功能失调可致言语错乱，更甚引起言语功能障碍[9]。

随着医疗水平的不断进步，寻求更加新型有效的治疗策略以提高运动性失语的恢复率，仍是我们亟待解决的医学难题。廖敏等[10]认为交流效果促进法能模拟日常生活交流中的自然语境，在此情境中，选择符合患者实际能力和需求的信息传递方式并完成信息传递的内容，相较与传统刺激法更容易被患者接受，也更能激发患者与他人交流的愿望。现代研究认为，运动性失语的发病机制与大脑优势半球的皮质语言中枢受损及语言功能区的相关联系纤维

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

损伤有关[11-12]。基于大脑神经的基本生理特性，选取与大脑皮层相互对应的刺激区进针，目的是为了促进病灶部位的气血运行，激活相应语言区域传导功能，加强病变脑内神经突触再生，帮助受损神经纤维的恢复，更好的发挥其代偿作用[13]，促使神经细胞的功能恢复。由此可见，针灸治疗具有激活语言神经功能，使与语言相关器官的大脑皮层之间的的联系逐渐加强的作用，有利于修复神经纤维及大脑皮质功能，使脑部逐步建立起侧支循环[14]，改善受损功能区域神经递质的活动能力，重新建立语言功能网络[15]。

笔者对运动性失语选取言语一区和言语三区是因为言语一区对应头面部的运动功能，对治疗存在发音障碍、语调异常的运动性失语疗效颇佳，而言语三区对应晕听区，可以改善患者的听力障碍，针刺该区可以提高其理解长句及复杂指令的能力。在临床上，脑卒中患者由于损伤到优势半球大脑的皮质语言中枢[16]，导致其理解和语言表达、阅读以及书写能力丧失，与他人沟通困难，因此对患者进行口、唇、舌型的言语训练以获得正确的发音显得尤为必要[17]。基于此，本研究选取言语一区和言语三区作为施针区域。

综上所述，运动性失语患者在口语理解、复述表达、命名、阅读及书写能力方面的不断进步，有赖于发挥头皮针联合言语康复训练的优势，是一种值得借鉴的治疗方法，临床上将两者结合，相辅相成，能不断开发患者残存的言语功能，以适应社区内的交流需要。但本研究还需要更多大样本、多中心的临床试验加以确证，以便更好的减轻卒中带给运动性失语患者的身心压力，使其早日融入家庭和社会。

参考文献：

［1］ 刘晓丽 . 早期语言康复训练改善急性脑卒中后失语症患者的效果观察 [J]. 中国实用神经疾病杂志 , 2017, 20(6):141-142.

［2］ 白俊敏 , 闫秀丽 , 吴明莉 , 等 . 互动式头针治疗中风后运动性失语的临床疗效 [J]. 时珍国医国药 , 2017, 28(6):1394-1396.

［3］ 汪洁 , 吴东宇 , 宋为群 , 等 . 双额叶在线经颅直流电刺激对失语症图命名的作用 [J]. 中国康复医学杂志 , 2014, 29(1):31-35.

［4］ 薛长青 , 张晓宇 . 头针针刺言语区配合语言康复训练治疗失语症临床观察 [J]. 中国现代药物应用 , 2017, 11(21):67-68.

［5］ 国家中医药管理局 . 中医病证诊断疗效标准 [M]. 南京 : 南京大学出版社 , 1994:23.

［6］ 中华神经科学会 , 中华神经外科学会 . 各类脑血管疾病诊断要点 [J]. 中华神经科杂志 , 1996, 29(6):379.

［7］ 张庆苏 , 纪树荣 , 李胜利 , 等 . 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析 [J]. 中国康复理论与实践 , 2005, 11(9):703-705.

［8］ 罗平 , 张淑忆 . 醒脑开窍法治疗假性延髓麻痹疗效观察 [J]. 上海针灸杂志 , 2010, 29(1):11-13.

［9］ 王富江 , 万全庆 , 解光尧 , 等 . 综合康复疗法治疗脑卒中后运动性失语的临床研究 [J]. 浙江中医杂志 , 2013, 48(12):870-871.

［10］ 廖敏 , 高立群 . 失语症言语治疗中的交流效果促进法 [J]. 中国听力语言康复科学杂志 , 2019, 17(1):71-73.

［11］ 郑海鹰 , 刘颖 , 姜丹丹 , 等 . 言语训练配合头皮针治疗失语症 30 例 [J]. 辽宁中医杂志 , 2014, 41(3):545-546.

［12］ 齐国豪 , 常宝燕 , 赵全忠 . 头皮针结合言语训练治疗中风后运动性失语 38 例 [J]. 光明中医 , 2017, 32(2):256-257.

［13］ 何金峰 , 徐小辉 , 茆红霞 , 等 . 针灸联合康复治疗脑卒中后运动性失语的临床疗效观察 [J]. 中华中医药学刊 , 2015, 33(3):763-765.

［14］ 宋兆瑛 , 刘俊双 , 刘兢 , 等 . 头针联合电针治疗缺血性脑卒中后失语症临床研究 [J]. 中国中医药信息杂志 , 2018, 25(7):21-24.

［15］ 金荣祥 , 张成 , 倪红雷 , 等 . 头针联合语言康复训练对脑卒中后运动性失语症患者的疗效研究 [J]. 新疆医科大学学报 , 2018, 41(12):1503-1507.

［16］ 田亮 , 王金海 , 孙润洁 , 等 . 头针治疗缺血性中风的机制研究进展 [J]. 针刺研究 , 2016, 41(1):87-89-93.

［17］ 蒋功达 , 周静 , 李海舟 . Broca 失语的语音障碍分析 [J]. 中国医药导刊 , 2014, 16(9):1189-1190, 1196.

（本栏责任编辑：赵 阳 收稿日期：2019-06-30）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net